并发症 ttsx 小结：

	胃食管反流病	十二指肠溃疡	胃溃疡	胃癌	肠结核	CD	UC
出血	√	√	√	√	√	√	√
穿孔	×	√	√	√	√	√	√见于中毒性巨结肠
梗阻	√	√	√	√	√	√	√见于铅管征
癌变	本身×	×	√	√		√	√

只要累及黏膜下层都可以出血　大量纤维化

并发症:上下班

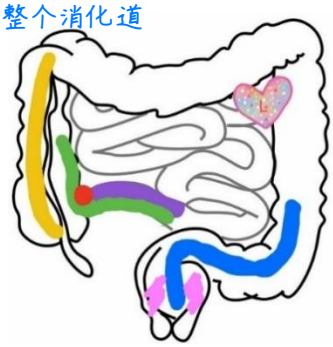
脓血小结：

多无脓血：肠结核、克罗恩病、肠伤寒、肠易激综合征（绝无脓血）　功能性疾病

多有脓血：溃疡性结肠炎、左边的克罗恩病、大肠癌尤其左侧、细菌性痢疾　阑尾炎可并发盆腔脓肿；还可见于腹盆腔手术术后

多有里急后重：溃疡性结肠炎、累及直肠的克罗恩病、直肠癌、细菌性痢疾、盆腔脓肿、坐骨肛管/直肠间隙脓肿

累及直肠　克罗恩可以累及整个消化道



- 肠结核　回盲部
- 伤寒　回肠末端
- 克罗恩病　回肠末端及邻近结肠
- 肠阿米巴　盲肠和升结肠
- 细菌性痢疾、血吸虫病、溃疡型结肠炎　直肠和乙状结肠
- 大肠癌　直肠和乙状结肠

四、控制炎症反应（升阶梯治疗）

（一）溃疡性结肠炎的治疗

1.氨基水杨酸制剂　类比支气管哮喘　发作期迅速缓解症状,慢性炎症长期抗炎

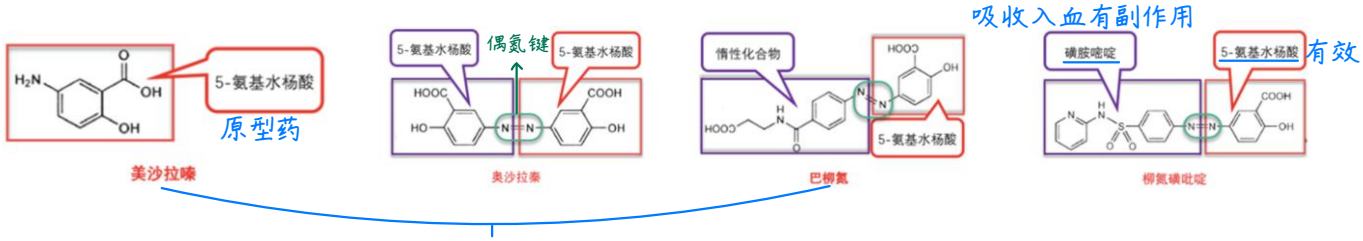
①用于轻、中度 UC 的活动期诱导缓解和缓解期维持治疗。5-ASA 灌肠剂适合病变局限在直肠和乙状结肠者，栓剂适合病变局限在直肠者

原型药和前体药决定了后4排的区别

②新型 VS 传统制剂：有无磺胺吡啶决定了有无吸收入血的副作用

ttsx	新型 美国的奥巴马（避免磺胺吡啶在小肠近段吸收入血的副作用）		传统
	美沙拉嗪（常用）	奥沙拉嗪、巴柳氮	柳氮磺吡啶 SASP
5-ASA 真正起作用的部分	原型不靠细菌	前体	前体
是否依赖细菌 切断偶氮键	× （依赖 pH 或时间）	√	√
与抗生素合用 有益	√	×	×
病变在大肠 大肠里的细菌才能打开偶氮键	√	√	√
病变在小肠	√	× 靠细菌打开偶氮键,但小肠比较"干净"	×

吸收入血有副作用



不含磺胺吡啶,避免了其吸收入血产生的副作用